

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA		
	No. Dokumen 935.64/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.
Pengertian	- Merupakan prosedur untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB). - Peningkatan insidensi kasus yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas, di suatu tempat terbatas. Hal ini terjadi jika terdapat ketidak seimbangan antara penjamu, agen, dan lingkungan: - Keberadaan patogen (agen yang menimbulkan penyakit) dalam jumlah cukup untuk menjangkiti sejumlah individu. - Terdapat modus transmisi patogen yang cocok kepada individu-individu rentan. - Terdapat jumlah yang cukup individu-individu rentan yang terpapar oleh patogen. - Kasus Probable (mungkin) adalah didapatkan gejala klinis atau lesi kulit yang sesuai dengan meningokokseミア, disertai : - Hasil kultur darah positif bakteri diplokokus gram negatif. - Hasil pemeriksaan langsung dan atau kultur swab tenggorok positif bakteri diplokokus gram negatif.	
Tujuan	- Mengidentifikasi agen kausa KLB, cara transmisi, sumber KLB, karier, populasi berisiko, paparan yang menyebabkan penyakit (faktor risiko). - Menghentikan KLB sekarang dan mencegah KLB di masa mendatang.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	Persiapan alat - Alat dan bahan kultur darah dan kultur swab tenggorok: - Botol kultur darah - Mesin kultur darah otomatis - medium Thayer Martin - Amies medium - Gelas obyek - Ose - Cat Gram - Mikroskop - Candle jar - Incubator - Disk antibiotika (Ciprofloxacin, Chloramphenicol, Ceftriaxone, Cefotaxim, Ceftazidim, Meropenem) - Antibiotika terapi profilaksis : ciprofloxacin tablet 500 mg, rifampicin tablet 600 mg, spiramycin tablet 500 mg	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA		
	No. Dokumen 935.64/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/3
	3. Antibiotika terapi kuratif: ceftriaxone injeksi, ceftazidime injeksi, chloramphenicol injeksi 4. Alat pelindung diri : masker, gaun, dan sarung tangan 5. Handrub 6. Sabun antiseptik 7. Tissue towel 8. Disinfektan berbasis chlorine 9. Tempat sampah infeksius Persiapan Petugas : 1. Perhatikan teknik aseptik dalam mengidentifikasi kasus, pengambilan sampel kultur, dan proses cleaning dan disinfecting. 2. Perhatikan ketepatan dalam mengidentifikasi kasus secara klinis dan laboratories. Pelaksanaan prosedur 1. Lakukan identifikasi KLB berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan mikrobiologis dalam 1 x 24 jam. 2. Laporkan hasil identifikasi KLB ke Tim PPI. 3. Tim PPI: koordinasikan dengan Tim PPI untuk menindaklanjuti laporan hasil identifikasi outbreak. 4. Lakukan investigasi kasus oleh Tim PPI bila perlu bekerjasama dengan Instalasi Mikrobiologi Klinik dalam 2x24 jam. Lakukan investigasi kausa meliputi definisi kasus dan epidemiologi deskriptif bersama Tim PPI dan Instalasi Mikrobiologi Klinik, dalam waktu ≤ 7 hari. Hasil investigasi 5. Sementara (interim report) disertai dengan rekomenda silangkah pencegahan dan pengendalian infeksi dikirim ke unit terkait diketahui oleh Direktur RS. 6. Lakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, untuk mencegah transmisi oleh Tim PPI dan unit terkait dalam waktu 1x24 jam. Mengeliminasi sumber pathogen: Dokter : Berikan terapi kuratif secara empiric sebelum hasil sensitifitas keluar dengan : 1. Ceftriaxone dosis 100 mg/kg BB/hari atau 2. Khloramfenikol dosis 100 mg/kg BB/hari, kecuali bayi di bawah usia 3 bulan atau didapatkan supresi sumsum tulang atau 3. Ceftazidime dosis 50 mg/kg BB/hari terbagi dalam 3 dosis. Antibiotika definitive diberikan sesuai hasil uji kepekaan antibiotika. Berikan terapi profilaksis terhadap: Petugas kesehatan: ciprofloxacin 500 mg per oral single dose Contact patients dan pasien tidak satu ruang dengan pasien meningococccemia namun berstatus immunocompromised (gizi buruk, HIV, penyakit kronis yang ditentukan DPJP masingmasing): 1. Ceftriaxone dosis 125 mg intramuskuler single dose (untuk pasien berat badan<30 kg), ceftriaxone dosis 250 mg intramuskuler single dose (untuk pasien berat badan>30 kg) atau 2. Rifampicin dosis 10 mg/kgBB 2 kali sehari selama 2 hari untuk anak-anak, 600 mg per oral 2 kali sehari selama 2 hari untuk		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA		
	No. Dokumen 935.64/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	dewasa atau 3. Spiramycindosis 25 mg/kgBB 2 kali sehari selama 5 hari untuk anak-anak, 1000 mg 2 kali sehari selama 5 hari untuk dewasa dan wanita hamil. Memblokade proses transmisi: 1. Perawat: Lakukan cohorting bila pasien dirawat diruang yang sama dengan pasien yang tidak menderita. 2. IRNA : a. Tutup sementara untuk pasien baru, pasien baru dirawat sebagai pengganti. b. Petugas kesehatan dan keluarga pasien: Tingkatkan kepatuhan cuci tangan (hand hygiene) bagi semua petugas kesehatan dan keluarga pasien Petugas kesehatan yang masuk keruangan untuk melakukan tindakan, visite dan cleaning: c. Gunakan alat pelindung diri (APD). 3. Perawat: a. lakukan cleaning dan disinfected terhadap lingkungan dan instrument di ruangan. b. Keluarga pasien yang menunggu gunakan masker. Mengeliminasi kerentanan/factor resiko: Lakukan skrining status karier dengan melakukan kultur swab tenggorok terhadap: a. Contact patients. b. Petugas kesehatan. c. Pasien baru pada saat MRS dan hari ke 5 MRS. d. Keluarga pasien. Tim PPI : laporkan laporan investigasi KLB beserta langkah pencegahan dan penanggulangan KLB kepada direktur rumah sakit dan jajaran terkait. Pimpinan rumah sakit: a. Bentuk tim KLB Probable Meningokoksemia di ruang. b. Sampaikan pernyataan resmi untuk menghindari keresahan kalangan petugas kesehatan rumah sakit. Dokumentasi laporan KLB, analisa dan rencana tindak lanjut dengan pimpinan rumah sakit. Kirim laporan kejadian kebidang evaluasi dan pelaporan.		
Unit Terkait	Seluruh instalasi. Komite PPI		